
Oclusão

Oclusão em Odontologia

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução à Oclusão	3
02 Relações Dentárias	4
03 Plano e Curvas de Oclusão	5
04 Contatos Oclusais e Cúspides	6
05 Movimentos Mandibulares	7
06 Tipos de Oclusão	8
07 Classificação de Angle	9
08 Estabilidade e Ajuste Oclusal	10
09 Articuladores	11
10 Referências	12

01

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Introdução à Oclusão

Conceito Geral

PONTOS-CHAVE

Oclusão é o contato entre os dentes dos arcos superior e inferior, envolvendo não só as estruturas dentárias, mas também o sistema neuromuscular e a articulação temporomandibular (ATM). Uma oclusão equilibrada é fundamental para a saúde funcional do sistema estomatognático.

Anatomia Funcional

Liga a mandíbula ao crânio e permite movimentos complexos (rotação e translação).

Envolve:

côndilo mandibular, osso temporal, disco articular, cápsula articular, líquido sinovial e ligamentos.

O disco articular divide a ATM em dois compartimentos: superior (translação) e inferior (rotação).

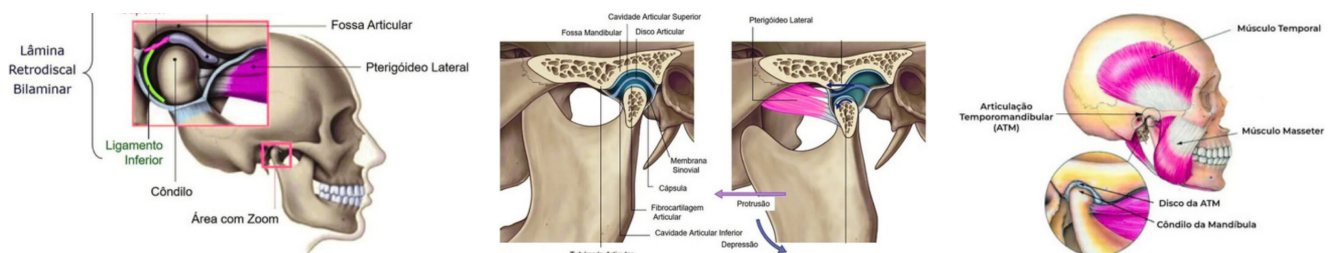
O equilíbrio dos movimentos depende do formato bicôncavo do disco e da pressão intra-articular negativa.

Controlado (proprioceptores,

Atua proteger

Sistema neuromuscular

por receptores sensoriais nociceptores, etc). para manter o equilíbrio mandibular e o sistema mastigatório de sobrecargas.



ANOTAÇÕES

02

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Relações Dentárias

Relação Central (RC)

PONTOS-CHAVE

Posição em que o côndilo está na parte mais superior e anterior da eminência articular, com disco corretamente posicionado. Não depende de contato dentário.

Máxima Intercuspidação (MI)

Maior número de contatos entre dentes antagonistas, independentemente da posição condilar. MI Habitual (MIH)

Posição que o paciente mais frequentemente adota na oclusão habitual. Pode haver desvio da RC para a MIH devido a contatos prematuros. Relação em Oclusão Cêntrica (ROC)

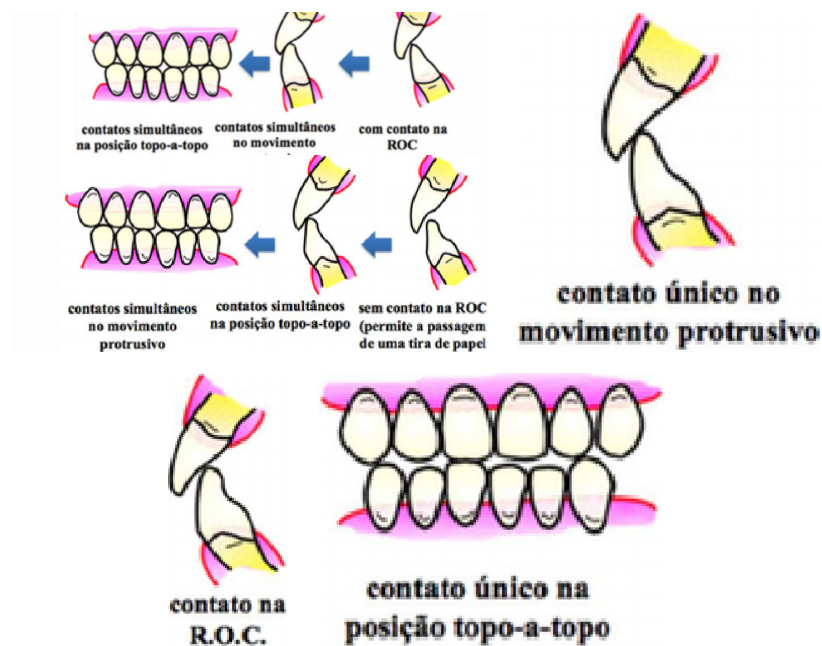
Coincidência entre RC e MI, é rara e considerada ideal.

Dimensão Vertical de Oclusão

Distância com dentes em contato.

DVR (Dimensão Vertical de Repouso): distância com dentes em repouso.

A diferença entre DVR e DVO forma o Espaço Funcional Livre (~2-3 mm).



ANOTAÇÕES

03

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Plano e Curvas de Oclusão

Plano de Oclusão

PONTOS-CHAVE

Relação tridimensional entre os dentes superiores e inferiores.

Pode ser normal, prognata ou topo-a-topo.

Curva de Spee

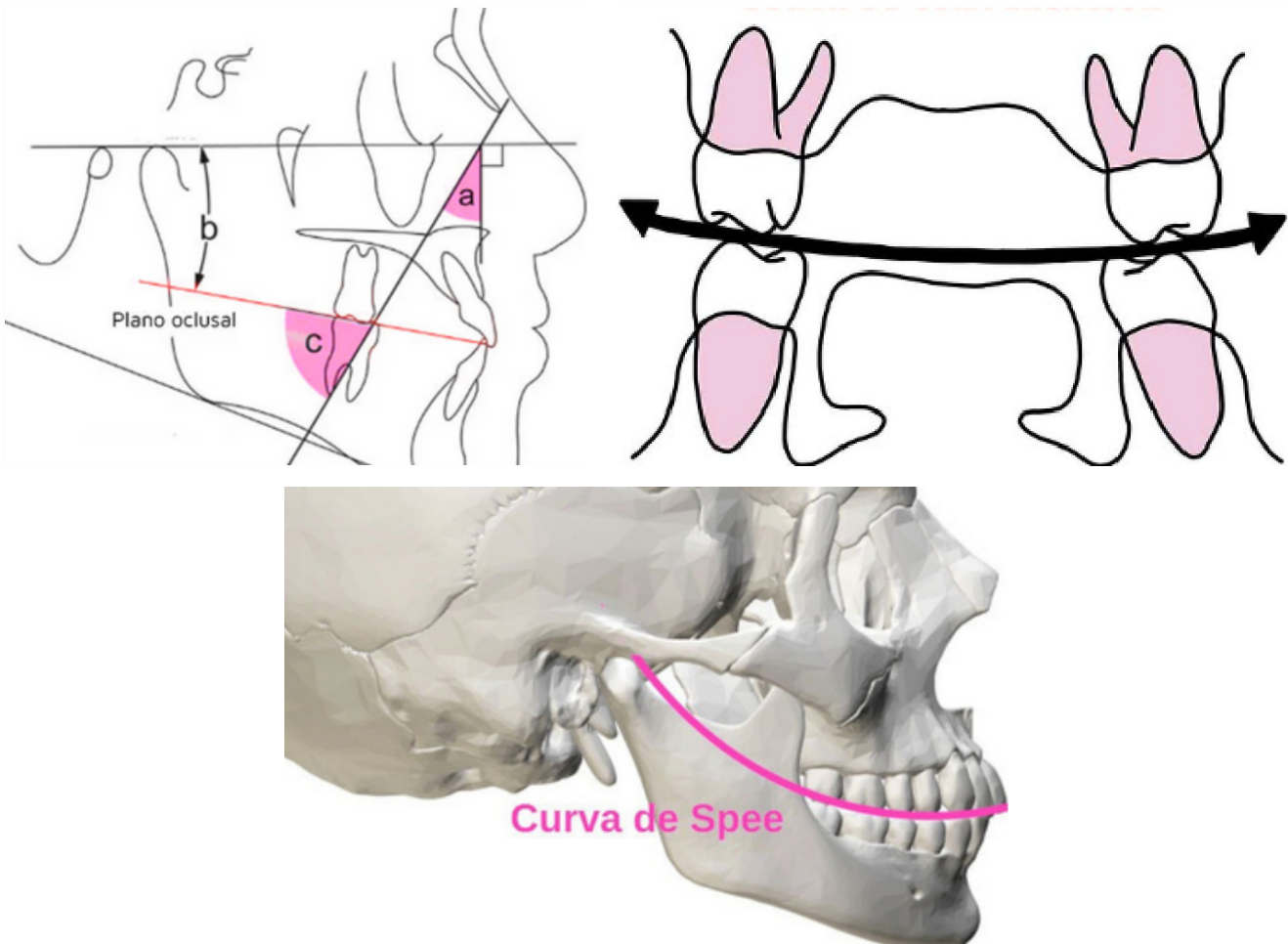
Vista lateral. Vai dos molares aos caninos.

Permite deslizamento mandibular em protrusão.

Curva de Wilson

Vista frontal. Liga cúspides vestibulares e linguais dos dentes posteriores.

Tem concavidade superior no arco inferior, relacionada à inclinação dos dentes.



ANOTAÇÕES

04

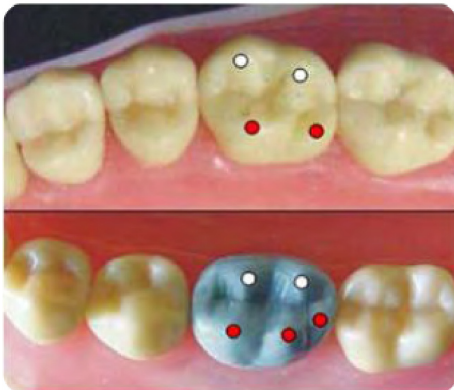
OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Contatos Oclusais e Cúspides

Cúspides funcionais (pontos vermelhos) e não funcionais (pontos brancos).

Contatos Oclusais e Cúspides

- **Cúspides funcionais (de contenção):**
 - Palatinas dos superiores e vestibulares dos inferiores.
 - Estabilizam a mordida e participam da trituração dos alimentos.
- **Cúspides não funcionais (de guia ou balanceio)**
 - Vestibulares dos superiores e linguais dos inferiores.
 - Ajudam nos movimentos mandibulares e protegem tecidos moles.
- **Modelos de contato:**
 - **Tripodismo (Peter Thomas):** uma cúspide toca três vertentes antagonistas.
 - **Cúspide-fóssula / cúspide-crista (Wiskott & Belser):** cada cúspide toca um único ponto – mais simples.

**Contatos Oclusais**

Todas as cúspides de trabalho ocluem nas fóssulas.

ANOTAÇÕES

05

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Movimentos Mandibulares

PONTOS-CHAVE

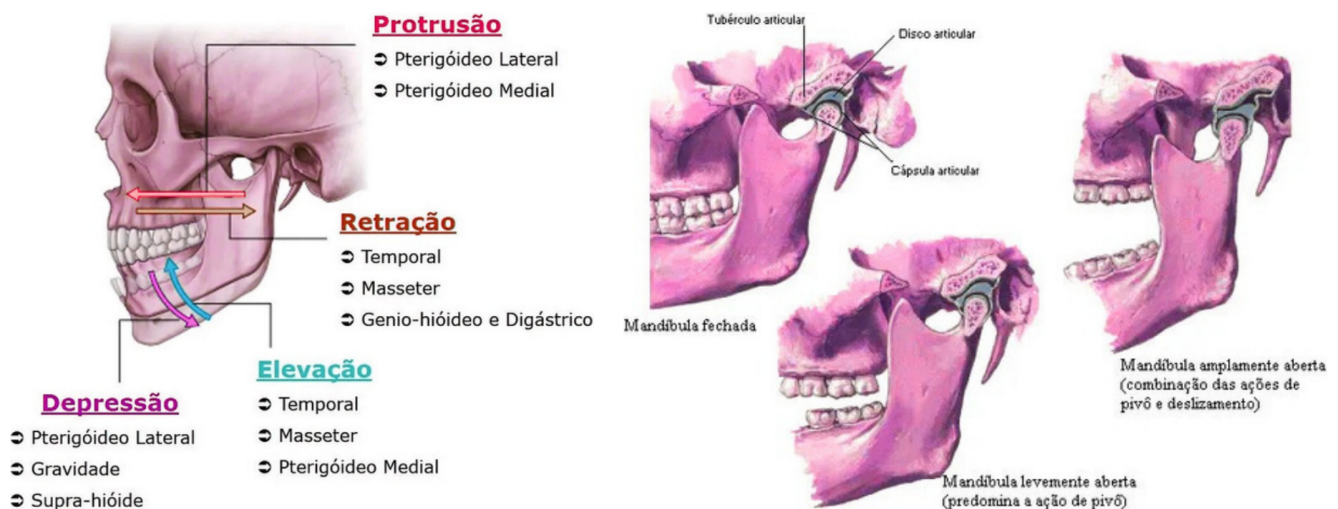
Abertura e fechamento

Protrusão e retrusão

Lateralidade

Lado de trabalho: o côndilo gira.

Lado de balanceio: o côndilo translada (movimento de Bennett – para frente, para baixo e para dentro).



ANOTAÇÕES

06

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Tipos de Oclusão

PONTOS-CHAVE

Oclusão ideal

RC coincide com MI.

Presença de guia canina.

Forças mastigatórias são axiais.

Oclusão fisiológica

Apresenta pequenos desvios da ideal, sem sinais clínicos negativos.

Oclusão patológica

Associada a sintomas clínicos como mobilidade dentária, recessões gengivais, abfrações e desgastes.

Oclusão Ideal



Dentes Tortos e Cruzados



Diastemas



Mordida Cruzada



Mordida Aberta



Oclusão Ideal



Mordida Profunda



Apinhamentos

ANOTAÇÕES

07

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Classificação de Angle

PONTOS-CHAVE

Classe I (neutroclusão)

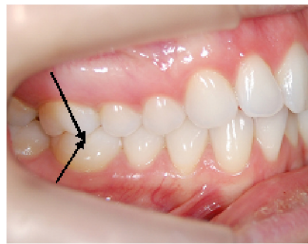
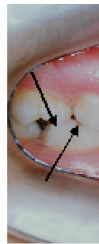
Cúspide méso-vestibular do 1º molar superior encaixa no sulco méso-vestibular do 1º molar inferior.

Classe II (distoclusão)

Cúspide do molar superior está à frente do sulco do inferior.

Classe III (mesioclusão)

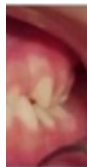
Cúspide do molar superior está atrás do sulco do inferior



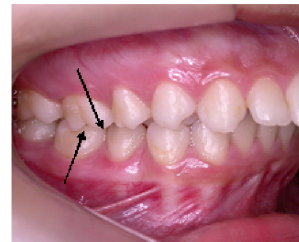
Classe II
Maxila avança a mandíbula



Classe II
Maxila avança a mandíbula



Mordida Cruzada
Mandíbula cobre parte da maxila



Mordida Profunda
Maxila cobre muito a mandíbula



Mordida Profunda
Maxila cobre muito a mandíbula



Apinhamento
Não há espaço para os dentes

ANOTAÇÕES

08

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Estabilidade e Ajuste Oclusal

Estabilidade Oclusal

PONTOS-CHAVE

Depende do equilíbrio entre forças horizontais e verticais.

A zona neutra é o ponto de equilíbrio entre ➤ músculos da bochecha, língua e lábios – essenciais para estabilidade dentária. ➤

Ajuste Oclusal

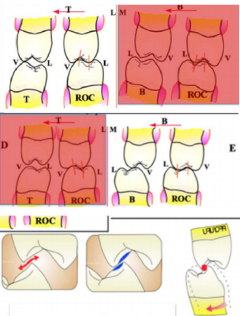
Indicações: Contatos prematuros, abfrações, mobilidade, reabilitações e pós-ortodontia. **Procedimento:**

Realizado com base na Relação Central.

Utiliza-se papel carbono e desgaste seletivo nas áreas de interferência (ex: cúspides de balanceio). **Regras gerais:**

Em lateralidade: eliminar contatos no lado de balanceio.

Em protrusão: eliminar contatos posteriores, mantendo a guia anterior.



ANOTAÇÕES

09

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Articuladores

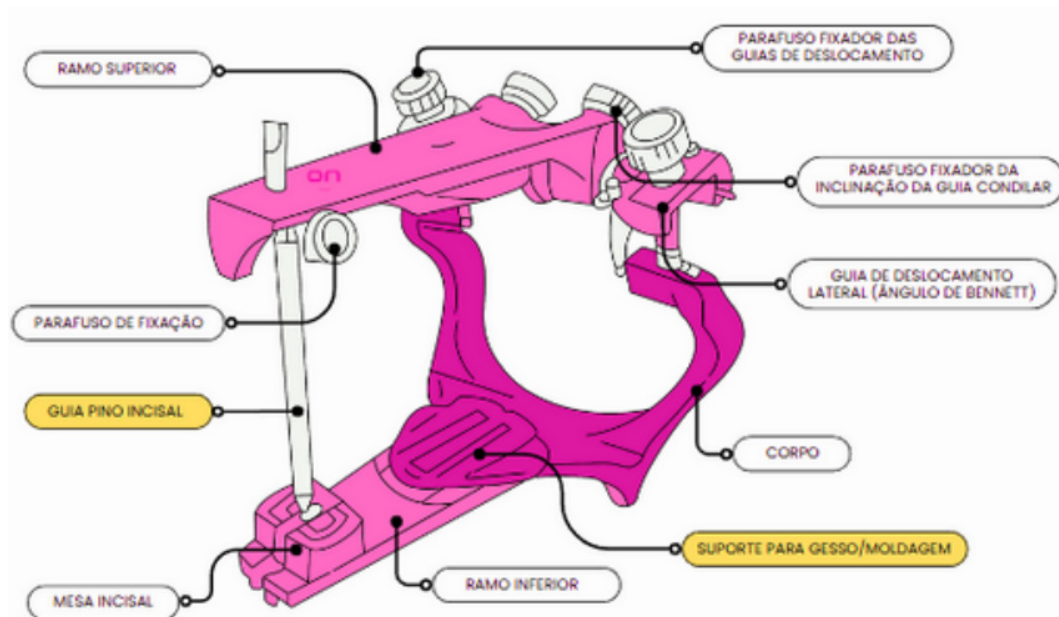
PONTOS-CHAVE

Simples: Reproduz apenas abertura e fechamento.

Semiajustável: Simula movimentos laterais e protrusivos.

Totalmente ajustável: Alta precisão, ideal para casos complexos.

Virtuais: Modelagem digital, ideal para planejamento digital e reabilitações.



ANOTAÇÕES

10

OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA

Referências

COSTA, Antonio de Pádua Cavalcante da; FARIAS, Isabela Albuquerque Passos; LEITE, Dayane Franco Barros Manguiera (org.). Anatomia e escultura dental. 3.ed.

Tratamento Das Desordens Temporomandibulares e Oclusão – Jeffrey Okeson – 7th

ANOTAÇÕES